КОНЦЕПЦИЯ / 01

Клинический компас

Помочь человеку рассказать о своем состоянии и подготовиться к разговору со специалистом.

Начинаем со студентов и молодых взрослых 18+. Приложение объясняет вопросы, собирает ответы и показывает их специалисту. Диагноз и план помощи определяет специалист.

1. Знакомство Короткое объяснение, FAQ и согласие.

2. Безопасность C-SSRS и понятный путь к помощи.

3. Короткий опрос PHQ-4: два вопроса о тревоге, два о депрессивных симптомах.

4. Уточнение и прием PHQ-9 / GAD-7; беседа и дополнительные формы по назначению.

5. Наблюдение Повторные формы, графики и темы для следующего разговора.



Присланная схема: сохраняем эту последовательность. Подробные пояснения открываются по желанию.

Главная идея. Меньше давления и лишних действий: можно сделать паузу, пропустить вопрос, добавить пояснение и отметить тему для беседы.

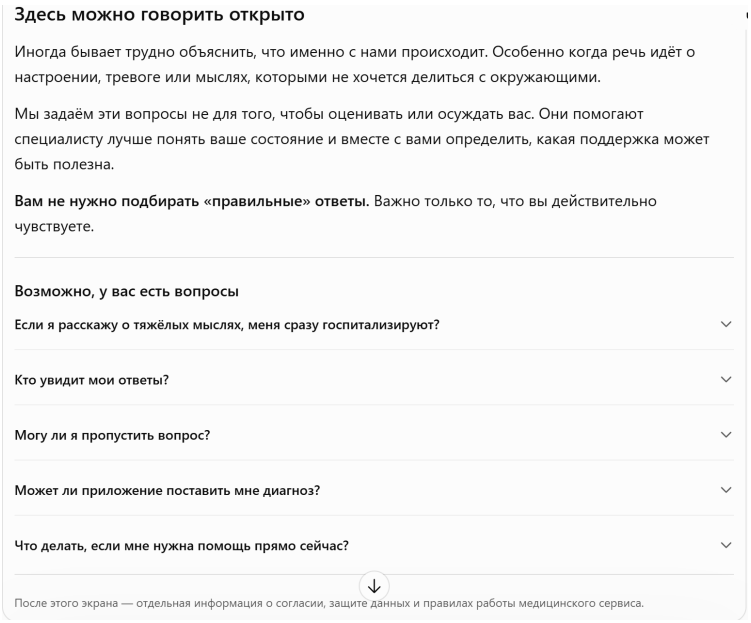
Как читать: страницы 1-6 - идея и экраны; 7-12 - русские формы. Это рабочий план прототипа для обсуждения с клиническим специалистом.

КОНЦЕПЦИЯ / 02

Перед первым вопросом

Даем короткое объяснение до анкет. Полный FAQ читать необязательно: человек открывает только то, что его волнует.

Вариант вступления.
Иногда трудно рассказать о настроении, тревоге или мыслях о смерти. Эти вопросы помогут специалисту лучше понять Ваше состояние и вместе с Вами обсудить помощь. Можно сделать паузу, пропустить вопрос или отметить, что Вы хотите обсудить его лично.



Присланный референс: приветствие и раскрываемые вопросы. Перед началом отдельно показываем реальные правила обработки данных.

Что важно объяснить	Короткий смысл
Кто увидит ответы?	Заранее назвать получателей и пределы конфиденциальности. Не обещать абсолютную тайну.
Если рассказать о мыслях о смерти?	Специалист уточнит, какая помощь нужна. Сам ответ не означает автоматическую госпитализацию; гарантировать ее отсутствие нельзя.
Можно задать свой вопрос?	Да: открыть FAQ или отправить личное обращение. Указать, кто и за какое время ответит.

Два разных варианта: FAQ без передачи личного вопроса можно читать без регистрации. Вопрос из аккаунта - конфиденциальный. Для настоящей анонимности нужен отдельный канал с проверкой того, какие данные он сохраняет.

Формулировки спокойные и прямые. Рядом с клиническим термином - простое объяснение; текст выбранной шкалы сохраняем. Исследовательская опора: [1] на странице 6.

КОНЦЕПЦИЯ / 03

Комментарий, голос и знак «!»

После стандартного ответа можно добавить текст или короткое голосовое сообщение. Это отдельное пояснение; оно не меняет выбранные баллы.

Фрагмент панели специалиста

PHQ-9, вопрос 4: чувство усталости или недостатка энергии

Ответ пациента: 2. Более половины времени

Комментарий

«Хочу пояснить, как это мешает учебе»

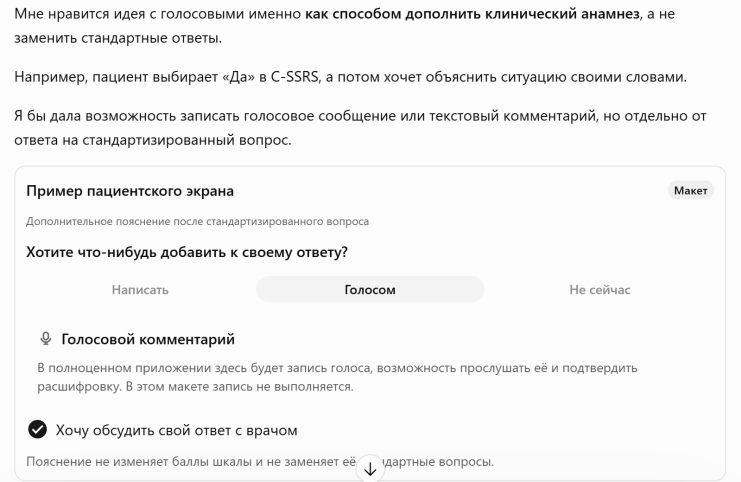
! Обсудить

Голосовое сообщение · 0:42

Прослушать · открыть расшифровку

! Обсудить

! = тема для разговора. Статус «Новое» показывается отдельно.



Присланный референс: текст, голос и возможность отметить ответ для беседы.

Действие	Что происходит
«Хочу обсудить»	Рядом с нужным текстом или аудио появляется «! Обсудить». Нажатие открывает дополнение и исходный вопрос.
Специалист прочитал	Статус «Новое» исчезает. «! Обсудить» остается, пока тема не разобрана; это разные признаки.
Голос	Например, до 60 секунд. Можно прослушать, удалить и проверить расшифровку. Исходная запись сохраняется отдельно.

Знак «!» - просьба уделить внимание теме, а не оценка опасности. Срочная помощь доступна отдельным действием. До отправки показываем фактическое время чтения сообщений; отправка не означает, что специалист уже их увидел.

КОНЦЕПЦИЯ / 04

Как работают графики

График появляется после повторного заполнения назначенных форм. Каждая точка - результат одной завершенной анкеты в конкретную дату. Ниже только вымышленные учебные данные.



Дата	PHQ-9, 0-27	GAD-7, 0-21	Сумма PHQ-ADS, 0-48
01.10	14	6	20
08.10	11	9	20
15.10	8	12	20

Что видно: депрессивные симптомы уменьшаются (14 → 8), тревожные усиливаются (6 → 12). Сумма остается 20 и скрывает разные направления. Поэтому основные линии - отдельные PHQ-9 и GAD-7; общая сумма необязательна.

Зачем нажимать на точку: специалист открывает дату и период анкеты, ответы по пунктам, комментарии, голос и «! Обсудить». Это помогает уточнить, с чем связано изменение, а не только увидеть число.

Простые правила. Вверх - больше выраженность симптомов по опроснику; вниз - меньше. Пропуск анкеты оставляет разрыв, а не 0. Повторяем ту же форму с инструкцией о последних двух неделях. Повторение назначает специалист.

PHQ-ADS = PHQ-9 + GAD-7. Только при двух полных сопоставимых шкалах одной сессии. Для выбранных русских переводов и студенческой аудитории обозначаем исследовательский статус. График и сумма не ставят диагноз и не заменяют отдельную оценку безопасности. Источник [5].

КОНЦЕПЦИЯ / 05

Что получает специалист

Одна понятная сводка: безопасность, результаты и динамика, дополнения пациента и темы для разговора. Исходные ответы доступны из каждого блока.

Безопасность - отдельный блок

Ответы C-SSRS, дата, пропуски и действия команды. Не прятать эту информацию внутри суммы PHQ/GAD.

Симптомы и динамика

PHQ-9, GAD-7, даты и полнота. Графики ведут к исходным ответам.

Темы к беседе

Комментарии, голос, «! Обсудить» и вопросы, на которые человек не ответил.

Видеоконсультация

До приема специалист видит назначенные анкеты. Во время разговора уточняет ответы и комментарии; при необходимости проводит врачебную шкалу. После - фиксирует свой вывод и следующий шаг. Для первой версии достаточно перехода в согласованный видеосервис.

Видеоформат требует подготовленного специалиста, приватности, подходящей связи и согласованного порядка помощи. Это не автоматический анализ лица или голоса.


да, если интервью дистанционно проводит специалист. И это подтверждено исследованиями.

Kobak et al., 2008 — дистанционная MADRS

В исследовании сравнили оценку депрессии при очном интервью, видеосвязи и телефонном разговоре. Для видеосвязи согласованность результатов была высокой: ICC = 0,94.

Читать исследование ↗ PubMed

Hamilton Depression Rating Scale — дистанционная оценка

В исследовании 2004 года оценка по видеосвязи показала высокую согласованность с очным интервью (ICC = 0,88). PubMed

А исследование 2025 года показало, что даже медицинским специалистам необходима подготовка для достаточно надёжного выставления баллов по HDRS-17. PMC

Поэтому я вижу три уровня автоматизации.

Присланный материал об исследованиях дистанционных врачебных оценок.

Дополнительная форма	Для чего и как
HCL-33	Самоотчет о периодах подъема. Назначает специалист для уточнения истории; 33 ответа «Да/Нет» и вопросы о длительности и последствиях. Не диагноз БАР. Полный присланный текст - на стр. 10-12.
MADRS / HDRS-17	Оценки выставляет подготовленный специалист по интервью и критериям выбранной формы, в том числе по видео, когда формат подходит и допустим. Итог - после подтверждения всех нужных пунктов.

ИИ, если понадобится позже, помогает с черновиком расшифровки. Он не исправляет ответы, не выставляет врачебные баллы и не принимает клинические решения. Источники [6], [8].

КОНЦЕПЦИЯ / 06

Что сделать сначала

Первая версия	Позже
Вступление, раскрываемый FAQ и согласие.	Отдельный канал анонимных вопросов.
Официальная C-SSRS и согласованный путь помощи; PHQ-4 с продолжением PHQ-9/GAD-7.	Подключаемые HCL-33 и врачебные шкалы.
Сохранение прогресса, пауза, пропуски, текст и «! Обсудить».	Голос и проверяемая расшифровка.
Сводка специалисту и две линии динамики.	Общий PHQ-ADS как исследовательское дополнение.

Правила подсчета. PHQ-2 = пункты 3+4 PHQ-4; GAD-2 = 1+2. Порог ≥3 по соответствующей подшкале ведет к предложению полной формы по утвержденному специалистом маршруту. Пропуск не равен нулю; неполной форме не присваиваем стандартный итог. Любой ответ >0 по пункту 9 PHQ-9 требует отдельного уточнения безопасности.

До работы с реальными пациентами: выбрать клинического партнера, точную русскую версию C-SSRS, права на формы, правила доступа к данным и ответственного за сообщения и срочные ситуации. FAQ остается доступен при отказе от анкет.

Ссылки, которые достаточно оставить под рукой

[1] McGillivray и соавт., 2022. Почему молодые люди не раскрывают мысли.
N=513; конфиденциальность, прямой вопрос и отсутствие осуждения важны для участников. Наблюдательное исследование, не проверка нашего интерфейса.

[2] Русская PHQ-4, 2024. [3] Русская PHQ-9, 2023.
[4] Русская GAD-7, 2023. Формы для пациента - далее.

[5] Kroenke и соавт., 2016. PHQ-ADS.
Обоснование общей суммы; не отдельный новый опрос и не доказательство валидности любой русской пары переводов.

[6] Mosolov и соавт., 2021. Русская HCL-33.
N=150 в клинической выборке; не автоматическая диагностика у всех студентов.

[7] Columbia: официальные переводы C-SSRS.
Нужную форму и режим заполнения выбираем с клиническим специалистом.

[8] Kobak и соавт., 2008. Дистанционная MADRS.
Согласованность оценок при подготовленных оценщиках; не замена беседы автоматическим баллом.

РУССКИЕ ФОРМЫ / 01

PHQ-4

Короткий вход: GAD-2 + PHQ-2. Порядок пунктов соответствует присланной русскоязычной форме.

Инструкция. Оцените, пожалуйста, насколько часто следующие проблемы беспокоили вас в течение прошедших двух недель. Для ответов используйте следующую шкалу:

0	1	2	3
Совсем нет	В течение нескольких дней	Более, чем половину этого времени	Почти каждый день

Проблема	0	1	2	3
1. Чувство тревоги или раздражения	0	1	2	3
2. Неспособность справиться со своим беспокойством	0	1	2	3
3. Снижение интереса и удовольствия от привычных дел	0	1	2	3
4. Чувство подавленности или безнадежности	0	1	2	3

Как читать результат

GAD-2: пункты 1+2, сумма 0-6.
PHQ-2: пункты 3+4, сумма 0-6.
Порог ≥3 применяется к каждой подшкале отдельно. Это повод для дальнейшей оценки, а не готовый диагноз.

> Если пункты соответствующей подшкалы не заполнены, итог по ней не вычисляется. PHQ-4 не складывается с C-SSRS.

Для реализации: сохранять точную формулировку, порядок и варианты ответа. Комментарий, голос или пропуск располагаются отдельно от стандартных ответов.

Источник: приложение к русской адаптации PHQ-4, 2024; ссылка [2] на странице 6. Верстка восстановлена из присланного текста.

РУССКИЕ ФОРМЫ / 02

PHQ-9

Опросник здоровья пациента. Русскоязычная форма из присланного приложения к статье А.А. Золотаревой, 2023.

Инструкция. Оцените, пожалуйста, насколько часто следующие проблемы беспокоили вас в течение прошедших двух недель. Для ответов используйте следующую шкалу:

0	1	2	3
Совсем нет	В течение нескольких дней	Более, чем половину этого времени	Почти каждый день

Проблема	0	1	2	3
1. Снижение интереса и удовольствия от привычных дел	0	1	2	3
2. Чувство подавленности или безнадежности	0	1	2	3
3. Проблемы со сном (неспособность заснуть, раннее пробуждение или слишком долгий сон)	0	1	2	3
4. Чувство усталости или недостатка энергии	0	1	2	3
5. Плохой аппетит или переедание	0	1	2	3
6. Плохое мнение о себе или чувство, что не смог оправдать ожиданий моей семьи	0	1	2	3
7. Проблемы с концентрацией внимания (например, при чтении газеты или просмотре телевизионной передачи)	0	1	2	3
8. Замедленность движений или речи, которая стала заметна другим людям, или, напротив, суетливость, когда движения и речь стали более быстрыми и беспокойными	0	1	2	3
9. Мысли о том, что мне бы хотелось умереть или причинить себе боль	0	1	2	3

Обработка. Сумма всех девяти ответов: 0-27. При ≥10 требуется дальнейшая клиническая оценка; результат сам по себе не устанавливает диагноз.

Безопасность. Любой ответ >0 на пункт 9 требует отдельного уточнения независимо от суммы. Пропуск не равен 0; стандартный итог неполной формы не формируем.

Источник: приложение к публикации 2023 года, DOI 10.17759/cpse.2023120406; ссылка [3]. Формулировки присланного текста сохранены.

РУССКИЕ ФОРМЫ / 03

GAD-7

Шкала генерализованного тревожного расстройства. Русскоязычная форма из присланной статьи А.А. Золотаревой, 2023.

Инструкция. Оцените, пожалуйста, насколько часто следующие проблемы беспокоили вас в течение прошедших двух недель. Для ответов используйте следующую шкалу:

0	1	2	3
Совсем нет	В течение нескольких дней	Более, чем половину этого времени	Почти каждый день

Проблема	0	1	2	3
1. Чувство тревоги или раздражения.	0	1	2	3
2. Неспособность справиться со своим беспокойством.	0	1	2	3
3. Чрезмерное беспокойство по разным поводам.	0	1	2	3
4. Неспособность расслабляться.	0	1	2	3
5. Ощущение такого беспокойства, что трудно найти себе место.	0	1	2	3
6. Склонность быстро испытывать злость или раздражительность.	0	1	2	3
7. Чувство страха, как будто может случиться что-то ужасное.	0	1	2	3

Как читать результат

Сложить все семь оценок: 0-21. 0-4 - минимальные, 5-9 - легкие, 10-14 - умеренные, 15-21 - тяжелые тревожные симптомы. Порог ≥10 - повод для дальнейшей клинической оценки, а не диагноз ГТР.

При пропуске стандартный итог не формируем. Если ответ не подходит человеку, он может оставить это в комментарии; программа не выбирает значение вместо него.

Источник: приложение к статье, DOI 10.17759/cpp.2023310402; ссылка [4]. Использован присланный перевод; он может отличаться от другой русской формы в клинических рекомендациях.

РУССКИЕ ФОРМЫ / 04

HCL-33: вопросы о состоянии

Рабочая копия присланного текста. 33 симптомных пункта - на следующих двух страницах. Перед внедрением сверить официальный текст и ключ выбранной формы; источник [6].

1. Прежде всего, укажите, как Вы сегодня, по сравнению с Вашим обычным состоянием:

Пожалуйста, выберите только одно утверждение из перечисленных:

☐ Намного хуже, чем обычно; ☐ Хуже, чем обычно; ☐ Немного хуже, чем обычно; ☐ Не лучше, не хуже, чем обычно; ☐ Немного лучше, чем обычно; ☐ Лучше, чем обычно; ☐ Намного лучше, чем обычно.

2. Как Вы обычно оцениваете себя по сравнению с другими людьми?

Вне зависимости от того, как Вы чувствуете себя сейчас, укажите, как Вы обычно воспринимаете себя с другими людьми. Выберите наиболее подходящую формулировку из перечисленных ниже. По сравнению с другими людьми мой уровень активности, энергичности и настроения... (Выберите одно утверждение.)

☐ ... всегда достаточно ровный и стабильный; ☐ ... обычно выше; ☐ ... обычно ниже; ☐ ... повторяющиеся периоды подъемов и спадов.

3. Попробуйте припомнить состояние «подъема».

Как Вы себя тогда чувствовали? Пожалуйста, ответьте на перечисленные утверждения вне зависимости от Вашего нынешнего состояния. Варианты «Да / Нет» для 33 пунктов - на стр. 11-12.

4. Влияние «периодов подъема» на разные аспекты Вашей жизни:

Для каждой сферы - **Семья / Общение / Работа / Досуг** - выберите один вариант: И положительное, и отрицательное / Положительное / Отрицательное / Никакого влияния.

5. Как Ваши близкие реагировали на Ваши «периоды подъема» и что они об этом говорили?

☐ Положительная реакция (Вас ободряли и поддерживали); ☐ Нейтральная реакция; ☐ Отрицательная реакция (озабоченность, раздражение, неодобрение); ☐ И положительная, и отрицательная реакция; ☐ Никакой реакции.

6a. Сколько длился Ваш самый долгий в жизни «период подъема»?

6b. Как правило (в среднем), сколько длится Ваш «период подъема»?

Для каждого вопроса отметьте один вариант: ☐ 1 день; ☐ 2-3 дня; ☐ 4-6 дней; ☐ 1-3 недели; ☐ 1 месяц или дольше; ☐ Мне трудно судить / Я не знаю.

7. За последние 12 месяцев были ли у Вас «периоды подъема»? ☐ Да / ☐ Нет.

8. Если да, попробуйте оценить, сколько дней Вы провели в состоянии подъема за последние 12 месяцев. Суммарно около _____ дней.

Два последних вопроса касаются Вашего темперамента:

9. Можете ли Вы сказать, что Вам по натуре свойственны периоды подъемов и спадов? ☐ Да / ☐ Нет.

10. Иногда для Вас характерны внезапные перепады настроения? ☐ Да / ☐ Нет.

В интерфейсе вопросы 4-10 идут после 33 симптомных пунктов. Здесь контекст собран на одном листе для компактности; он не включается в сумму 0-33. Технические подписи рисунков удалены, пунктуация нормализована.

РУССКИЕ ФОРМЫ / 04 · ПРОДОЛЖЕНИЕ

HCL-33: пункты 1-17

Попробуйте припомнить состояние «подъема». Как Вы себя тогда чувствовали? Пожалуйста, ответьте на перечисленные утверждения вне зависимости от Вашего нынешнего состояния. Для каждого пункта - «Да» или «Нет».

В этом состоянии:	Да	Нет
1. Мне требуется меньше сна		
2. Я чувствую себя более энергичным и активным		
3. Я более уверен в себе		
4. Работа доставляет мне больше удовольствия		
5. Я более социально активен (чаще звоню по телефону, чаще развлекаюсь)		
6. Мне хочется больше путешествовать и/или я больше путешествую		
7. Я вожу автомобиль с большей скоростью или чаще рискую во время вождения		
8. Я трачу больше денег, чем обычно (слишком много денег)		
9. Я чаще рискую в повседневной жизни (на работе или в других ситуациях)		
10. Я более активен физически (спорт и т.д.)		
11. Я планирую больше действий и проектов		
12. У меня больше идей, я становлюсь более креативным		
13. Я становлюсь менее застенчивым и "закомплексованным"		
14. Я одеваюсь и/или крашусь более ярко и экстравагантно		
15. Мне хочется встречаться с большим количеством людей или я действительно чаще общаюсь с людьми		
16. Я больше интересуюсь сексом и/или я становлюсь более сексуально активным		
17. Я больше говорю		

Продолжение основного блока - далее. Контекстные вопросы сохранены отдельно на странице 10.

РУССКИЕ ФОРМЫ / 04 · ПРОДОЛЖЕНИЕ

HCL-33: пункты 18-33

Продолжение того же основного блока о состоянии подъема. Для каждого пункта выбирается «Да» или «Нет».

В этом состоянии:	Да	Нет
18. Я думаю быстрей		
19. Во время разговора я чаще шучу и "каламбурю"		
20. Я легко отвлекаюсь		
21. Я вовлекаюсь во множество новых вещей		
22. Мои мысли перепрыгивают с одной темы на другую		
23. Я все делаю гораздо быстрее и/или легче, чем обычно		
24. Я более нетерпелив и/или легче раздражаюсь		
25. Я могу быть утомительным или раздражать окружающих		
26. Я чаще вступаю в ссоры		
27. Мое настроение более приподнятое и оптимистичное		
28. Я пью больше кофе		
29. Я выкуриваю большее число сигарет		
30. Я пью больше алкоголя		
31. Я принимаю больше лекарств (седативных, анксиолитиков, стимуляторов.)		
32. Я чаще играю или увлекаюсь азартными играми		
33. Я больше ем или я больше переедаю		

Подсчет: число ответов «Да» только в 33 симптомных пунктах, диапазон 0-33. Контекстные вопросы не прибавляем. При пропусках полный итог не формируем; ничего не проставляем автоматически.

Итог и исходные ответы видит специалист. Точный порог выбранного ключа нужно подтвердить перед реализацией. Высокая сумма сама по себе не устанавливает биполярное расстройство.